

TEMA 1.22 • CARDIOLOGÍA

Infarto del Ventrículo Derecho

PERFIL EUNACOM 1.01.2.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **infarto de ventrículo derecho (VD)** es una complicación grave del **Infarto Agudo al Miocardio (IAM)**, a menudo asociado a infartos de la pared inferior. Su reconocimiento es crucial debido a un manejo terapéutico específico.

Clínica del Infarto de Ventrículo Derecho

- Se caracteriza por una tríada clínica distintiva:
- **Hipotensión arterial:** Disminución de la presión arterial sistémica.
- **Ingurgitación yugular:** Distensión de las venas yugulares.
- **Ausencia de edema pulmonar agudo:** A diferencia del **Insuficiencia cardíaca|shock cardiogénico** por disfunción del ventrículo izquierdo, el VD infartado no bombea suficiente sangre a los pulmones, evitando el encharcamiento pulmonar.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La clínica de **hipotensión + ingurgitación yugular sin edema pulmonar** es altamente sugestiva de infarto de VD o **Taponamiento pericárdico**.

Asociación con Infarto de Pared Inferior

El infarto de VD se asocia frecuentemente a infartos de la pared inferior, ya que la arteria descendente posterior (rama de la coronaria derecha en la mayoría de los pacientes) irriga tanto la pared inferior del ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho. Por lo tanto, ante un IAM inferior, especialmente si el paciente está en shock, se debe sospechar y buscar activamente un infarto de VD.

Diagnóstico Diferencial con Rotura de Pared Libre

Es fundamental diferenciar el infarto de VD de la **rotura de pared libre cardíaca**, que también se presenta con hipotensión e ingurgitación yugular debido a un **Taponamiento pericárdico**. Las diferencias clave son:

TABLA 1.22.1: CARACTERÍSTICA VS INFARTO DE VENTRÍCULO DERECHO

CARACTERÍSTICA	INFARTO DE VENTRÍCULO DERECHO	ROTURA DE PARED LIBRE
IAM Asociado	Principalmente infartos de pared inferior	Infartos anterolaterales extensos
Tiempo de Aparición	Desde el inicio del infarto (precoz)	Varias horas o días después del infarto

Diagnóstico Electrocardiográfico

- El diagnóstico definitivo se realiza mediante un **Electrocardiograma** con **derivaciones precordiales derechas**.
- Se observará un **supradesnivel del segmento ST en V4R** (o V4-Derecha).
- Estas derivaciones no son parte del ECG convencional, por lo que deben solicitarse específicamente.

Manejo Terapéutico Específico

El tratamiento del infarto de VD difiere del manejo de otros tipos de IAM, principalmente en la estrategia de fluidos y el uso de fármacos.

- **Fluidoterapia con suero fisiológico:**
- - Administrar volumen de forma generosa (suero fisiológico) ya que el VD infartado es precarga dependiente. El paciente está hipotenso y no desarrollará edema pulmonar debido a la falta de fuerza del VD para enviar sangre a los pulmones.
- **Angioplastia urgente:**

- - Es el tratamiento de elección y debe realizarse de manera urgente para restaurar el flujo sanguíneo en la arteria coronaria derecha.
- **Antiagregación y anticoagulación:**
- - Mantener la terapia estándar para el IAM:
- - **Aspirina**
- - **Clopidogrel**
- - Heparina de bajo peso molecular
- - Estatinas
- **Evitar fármacos hipotensores:**
- - **Contraindicación absoluta** de cualquier medicamento que pueda disminuir la presión arterial, ya que el paciente ya está hipotenso y es precarga dependiente.
- - Esto incluye:
- - **Morfina**
- - **Nitroglicerina**
- - **Verapamilo**
- - **Estreptoquinasa** (trombolítico, también contraindicado por el shock y la posibilidad de angioplastia).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En el infarto de ventrículo derecho, está **ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADO** el uso de fármacos que disminuyan la precarga o la presión arterial, como nitratos, morfina o verapamilo. La trombolisis también está contraindicada en pacientes en shock.

Conclusión

El infarto de ventrículo derecho es una entidad clínica importante que requiere un alto índice de sospecha, especialmente en el contexto de un IAM inferior con shock. Su diagnóstico precoz mediante precordiales derechas y un manejo específico que prioriza la fluidoterapia y la revascularización urgente, mientras se evitan fármacos hipotensores, son clave para mejorar el pronóstico.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 66 años ingresa por IAMSDST inferior. PA 80/40 mmHg, FC 55 lpm, ingurgitación yugular severa con campos pulmonares limpios."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Tríada de IAM de Ventrículo Derecho: Hipotensión, Ingurgitación yugular y Pulmones limpios en IAM inferior. Tratamiento: Sobrecarga de Volumen con Suero Fisiológico EV. CONTRAINDICADOS Nitratos y Diuréticos.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El infarto del VD se asocia a IAM inferior por oclusión proximal de la coronaria derecha
- La tríada clásica es hipotensión, campos pulmonares limpios e ingurgitación yugular
- V4R es la derivación más sensible para diagnosticar infarto del VD
- La nitroglicerina, morfina y diuréticos están contraindicados porque reducen la precarga
- El tratamiento es carga de volumen agresiva para mantener precarga del VD
- La dobutamina se agrega si persiste hipotensión tras volumen adecuado
- La reperfusión precoz es fundamental para la recuperación del VD

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INFARTO DEL VENTRÍCULO DERECHO)

PREGUNTA 1

Paciente con IAM inferior, PA 80/50, campos pulmonares limpios, ingurgitación yugular. Se administra nitroglicerina y la PA cae a 60/30. ¿Cuál es el diagnóstico y el error?

- A)** Shock cardiogénico izquierdo, debió darse dobutamina
- B)** Infarto del VD, la nitroglicerina está contraindicada
- C)** Taponamiento cardíaco, requiere pericardiocentesis
- D)** TEP masivo, requiere trombolisis
- E)** Hipovolemia, dar más volumen solamente

PREGUNTA 2

Paciente con IAM inferior e hipotensión. ¿Qué derivaciones del ECG debe solicitar para confirmar infarto del VD?

- A)** Derivaciones posteriores V7-V9
- B)** Derivaciones derechas V3R-V4R
- C)** Derivaciones altas V1-V2 un espacio intercostal arriba
- D)** Solo las 12 derivaciones estándar
- E)** Derivaciones esofágicas

PREGUNTA 3

Paciente con infarto del VD confirmado, hipotenso. Se administran 2 litros de suero fisiológico sin mejoría. ¿Cuál es el siguiente paso?

- A)** Más volumen, hasta 4 litros
- B)** Dobutamina endovenosa
- C)** Furosemida endovenosa
- D)** Nitroglicerina endovenosa
- E)** Noradrenalina

RESUMEN: INFARTO DEL VENTRÍCULO DERECHO

El infarto del ventrículo derecho (VD) ocurre como extensión del infarto inferior cuando la oclusión de la coronaria derecha es proximal. Se presenta en hasta un 40% de los IAM inferiores y tiene implicancias terapéuticas fundamentales porque el manejo difiere significativamente del infarto izquierdo habitual. La presentación clínica clásica incluye la triada de hipotensión, campos pulmonares limpios e ingurgitación yugular. La ausencia de congestión pulmonar diferencia el compromiso del VD del shock cardiogénico izquierdo. El diagnóstico se confirma con ECG de derivaciones derechas que muestra SDST en V3R y V4R (siendo V4R la más sensible), y con ecocardiograma que muestra dilatación y disfunción del VD. El tratamiento se basa en la carga de volumen agresiva para mantener la precarga del VD, ya que este depende del retorno venoso. Están absolutamente contraindicados los fármacos que reducen precarga: nitroglicerina, morfina, diuréticos e IECA en fase aguda. Si a pesar del volumen persiste la hipotensión, se agrega soporte inotrópico con dobutamina. La perfusión precoz de la coronaria derecha es fundamental para la recuperación de la función del VD.